1. FLUXO DA REGULAÇÃO AMBULATORIAL DE CONSULTAS E EXAMES

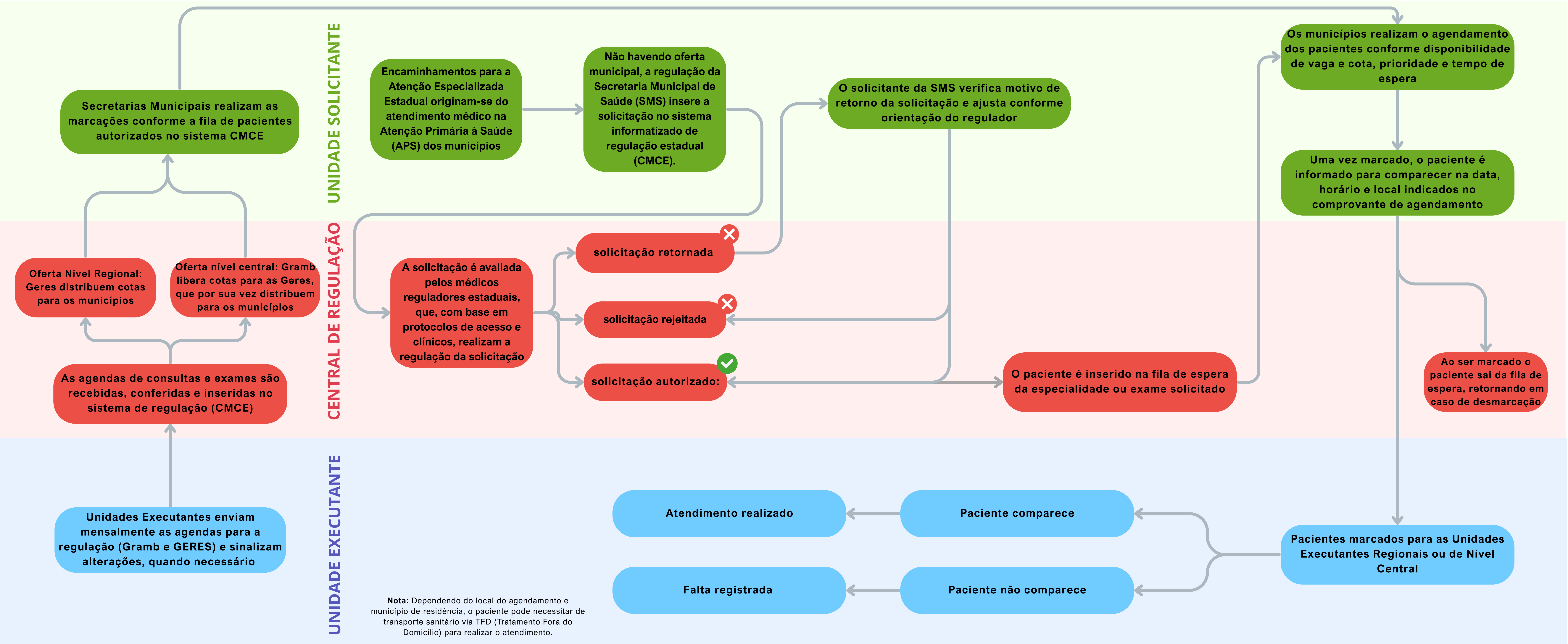
Encaminhamentos com informações incipientes

Inobservância e/ou desatualização dos protocolos de regulação

Inserção em especialidades (itens de agendamento) incorretos

Solicitações de retorno não atendidas ou ausência de fato das informações solicitadas

O agendamento nem sempre é feito em tempo oportuno, causando perda de vagas, falta de acompanhamento das vagas disponíveis ou ausência de solicitação de remanejamento de cotas.



UNIDADE SOLICITANTE

Secretarias Municipais realizam as marcações conforme a fila de pacientes autorizados no sistema CMCE

Encaminhamentos para a Atenção Especializada Estadual originam-se do atendimento médico na Atenção Primária à Saúde (APS) dos municípios

Não havendo oferta municipal, a regulação da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) insere a solicitação no sistema informatizado de regulação estadual (CMCE).

O solicitante da SMS verifica motivo de retorno da solicitação e ajusta conforme orientação do regulador

Os municípios realizam o agendamento dos pacientes conforme disponibilidade de vaga e cota, prioridade e tempo de espera

Uma vez marcado, o paciente é informado para comparecer na data, horário e local indicados no comprovante de agendamento

CENTRAL DE REGULAÇÃO

Oferta Nível Regional: Geres distribuem cotas para os municípios

Oferta nível central: Gramb libera cotas para as Geres, que por sua vez distribuem para os municípios

As agendas de consultas e exames são recebidas, conferidas e inseridas no sistema de regulação (CMCE)

A solicitação é avaliada pelos médicos reguladores estaduais, que, com base em protocolos de acesso e clínicos, realizam a regulação da solicitação

solicitação retornada ✗

solicitação rejeitada ✗

solicitação autorizado: ✓

O paciente é inserido na fila de espera da especialidade ou exame solicitado

Ao ser marcado o paciente sai da fila de espera, retornando em caso de desmarcação

UNIDADE EXECUTANTE

Unidades Executantes enviam mensalmente as agendas para a regulação (Gramb e GERES) e sinalizam alterações, quando necessário

Atendimento realizado

Paciente comparece

Falta registrada

Paciente não comparece

Pacientes marcados para as Unidades Executantes Regionais ou de Nível Central

Nota: Dependendo do local do agendamento e município de residência, o paciente pode necessitar de transporte sanitário via TFD (Tratamento Fora do Domicílio) para realizar o atendimento.

Remanejamento estratégico e ágil de vagas disponíveis

Visualização dinâmica das vagas disponíveis, facilitando o agendamento

Cadastros de pacientes desatualizados, dificultando ou impossibilitanto contato

Desmarcações sem aviso em tempo oportuno para remanejamento e aproveitamento da vaga

Marcação de pacientes fora de perfil para a unidade solicitada

Perdas Primárias

Dinamicidade de vagas disponíveis

Acompanhamento, gestão e higienização de Filas de Espera

Dificuldades de acessibilidade: disponibilidade de transporte sanitário e localização da Unidade Executante

Marcações sem contato com paciente

Perda Secundária

Alterações na agenda, com ou sem pacientes marcados, podem gerar transtornos e afetar a quantidade de vagas ofertadas

Resistência à prática de overbooking, o que dificulta o preenchimento total das vagas disponíveis, considerando potencial de faltas

Quando as Unidades Executantes não registram corretamente a realização do atendimento, pacientes que compareceram são contabilizados como faltas pelo sistema

🚨 **LEGENDA: FRAGILIDADES NO FLUXO.**